



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : سماح حامد حماد حسين
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : العياط
رقم البطاقة : 28807272100302 رقم التليفون : 01127125642
العنوان : قرية بيدف
العمر (تاريخ الميلاد) : 27-07-1988 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 27-09-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مسح ذري علي العظام [12966] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سماح حامد حماد حسين National ID: 28807272T00302	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bone scintigraphy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تعريف شخصية

سماح
حامد حماد حسين
قرية بيدف
مركز العياط - الجيزة

١٩٨٨/٠٧/٢٧

٢٨٨٠٧٢٧٢١٠٠٣٠٢

LV4623513

٠١١٤٩٩٧٦١٦٥

٠١١٢٧١٢٥٦٤٢

عصه ٢/١٢



٢٠٢٦/٠٧

٢٨٨٠٧٢٧٢١٠٠٣٠٢

ربة منزل



متزوجة

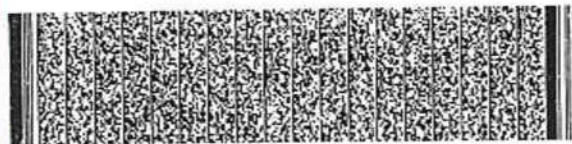
مسلمة

انثى

سيد عوده عواد محمود

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٣/٠٧/٠٦

١



PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: سماح حامد حماد حسين Age: 38 years Sex: female
Request type: مبادره Sub request type:
Hospital no: Pathology no.: 625-2026
Department: صحة مرآه Date of result: 26/7/2026
Referred by: د/مروه حسن Date of biopsy: 13/7/2026
Nature of specimen: tru-cut biopsy I.D. Number: 28807272100302
Clinical diagnosis: Left breast mass

Gross pathology:

Multipile grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture: Section examined revealed core of tumor showing invasive duct carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nests, tubule and cribriform pattern infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing moderate anaplasia and moderate tendency to form tubules. There is moderate number of mitotic figures. No carcinoma insitu component is seen.

Immunohistochemical Result:

ER: Moderate nuclear staining in 60% of tumor cells (Allred Score 6/8).

PR: Moderate nuclear staining of 70% of tumor cells (Allred Score 7/8).

Her2: Moderate complete membranous staining in >10% of tumor cells (score 2+) For SISH.

Ki67: Positive nuclear staining of 70% of tumor cells.

Diagnosis: Left breast mass, tru cut biopsy:

Invasive Duct Carcinoma, (NST) Grade III.

Signature:

Dr. Nermine Nabil M.D

Dr. 29/7/2026

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

Name: سماح حامد حماد حسين		GUSTAVE ROUSSY	
MR. : 13133			
Detailed Medical Report			
			السيد
تحتية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
		رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
The patient is a 38-year-old pre-menopausal individual with no reported family history of malignancy and no co-morbidities. The clinical history notes a left-sided breast cancer diagnosed as invasive ductal carcinoma, grade III, with documented metastases to the liver and lymph nodes. The patient is married, has four offspring, and the disease course includes recent computed tomography performed on 8/9/2026. Pathology from the core biopsy confirms invasive ductal carcinoma, grade III. Immunohistochemistry demonstrates estrogen receptor positivity in 7/8 cores, progesterone receptor positivity in 8/8 cores, HER2 3+ amplification, and a Ki-67 proliferation index of 50%. Imaging reveals a pulmonary nodule in the anterior segment of the upper lobes measuring 26 × 21 mm, pre-tracheal lymphadenopathy 26 × 22 mm, tracheal strip lymph nodes 29 × 28 mm, carinal/subcarinal nodes 24 × 14 mm, aortopulmonary nodes 39 × 15 mm, and multiple hepatic focal lesions with the largest measuring 26 × 22 mm, consistent with metastatic disease. The referring team recommends a regimen of taxol combined with herceptin. The multidisciplinary team concurs with this recommendation and plans to initiate taxol/herceptin therapy.			
تحريراً في ,			
		التاريخ : 23-09-2026	الوقت :
		الطبيب المعالج :	
يعتمد ,			

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الادارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول
الرقمي

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار: 2026-7-13

جهة الاصدار: فرع الجيزة

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) سماح حامد حماد حسين بطاقة رقم 28807272100302
تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة: 2026-7-13

الموظف المختص

احمد ياسر



افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،



مسلسل 2021303

الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الادارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول الرقمي

Patient ID: 070726-153419	Patient Name English: Samah hamed^Samah hamed
Age	2026/07/07 01:54:38 PM :Report Date

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 38 years old female complaining of left axillary lump, no family history.

Left breast:

- Dense fibro glandular density (ACR density C).
- A left LOQ rounded density with distortion seen related to the margin of the lesion
- Ultrasound
- A left LOQ (4-5 o'clock) middle zone, oval hypoechoic lesion with central vascularity seen within by color Doppler with indistinct margin medially measures 29 x15 mm 3cm from the nipple a small near by satellite 3mm in diameter
- Normal nipple/areolar complex.
- Pathological level I (the largest 18mm in the longitudinal axis), level II (19mm in the longitudinal axis), level III, infraclavicular, supraclavicular and lower deep cervical pathological LNS with diffuse cortical thickening

Right breast:

- Dense fibro glandular density (ACR density C).
- No dense lesion or asymmetry.
- Ultrasound
- Homogenous glandular lesion with no solid or cystic lesion
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Right nonspecific axillary LNS
- impression:
- Left breast (BIRADS 5): LOQ malignant mass lesion as described with suspected intraductal extension, associated with pathological level I,II,III, supraclavicular and lower deep cervical Lymph nodes .
- Right breast (BIRADS 1): normal
- Recommendation: For Tru cut core needle biopsy.

*Much obliged,
Dr. Omneya Ahmed MD*

GUSTAVE/
ROUSSY
INTERNATIONAL
HOSPITAL

أستاف
روسي
الطريقه
الدولية

ECHO REPORT

NAME: عبدالله / عبدالله DATE: 27/9/2026
ID NUMBER: / SEX: AGE:

EF	<u>68%</u>	55-75%	PWT	<u>0.8</u>	0.6-1.1cm
LVEDD	<u>4.5</u>	3.5-5.8cm	AO.R	<u>2.3</u>	3-3.7cm
LVESD	<u>2.3</u>	2-4cm	LA	<u>3.6</u>	2-4cm
FS	<u>30%</u>	25-45%	RV		0.7-2.3com(supine)
SWT	<u>0.9</u>	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV Dimensions Normal
LV Wall Thickness Normal
LV Diastolic Function Normal
SWMA Normal
LA and Ao Root Dimensions Normal
Mitral Valve Normal
Aortic Valve Normal
Tricuspid Valve Normal
Pulmonary Valve Normal
Right Side and Systolic Function Normal
Intracardiac Masses and Effusion Normal

DR.

جوسافة
رئيسة
9 - 21



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

مبادرة
الرئيس
الجمهورية

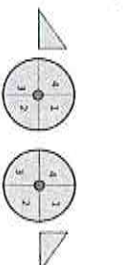
09/21/2026

MDT FORM

Name:	سماح طاهر حنين	MRN:	13133
Age:	38 Y	ID:	28807272100302
Menopausal St:	pre	Phone:*	01127125642
NRS SCORE:		Marital Status:	married
BMI:		Family History:	-ve
Gender		Reason Of MDT:	
CO Morbidity:	free	new case	
Surgical History:*	free	ECOG Performance Status	
		0 1 2 3 4	

Clinical Data:

BX: IDC GIII
ER: 7/8 **PR:** 8/8 **HER2:** 3+ **KI67:** 50%
History:
 38 married 4 offspring MF left breast cancer mets to liver and Lns Bc IDC GIII Er 7/8 , pr 8/8 her 3+ ki67 50% CTS 8/9/2026 ; pulm nodule in ant segment of upper pulm lobes 26x21mm prettracheal LNa 26x22 , trache strip LNs 29x28mm carinal subcardinal lns 24x14mm aorto pulm Lns 39x15mm , multipir HFLs largest 26x22mm



T N M

Right Side				Left Side			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

Sonomammography:

Biomarker/Molecular

Clinical Staging:

MBC

Mets Workup:

Pathological Staging:

Recommendations:
for taxol/herceptinMDT Outcome & Plan
porta cath
for taxol/herceptin

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د. زينب مسلمان	د. محمد طه لوي		

Patient's Name: Samah Hamid Hamad Hussein

Date: 2026-09-08

Referred by: Prof.Dr. no doctor

Hospital: Goustave Roussey International Egypt

**MULTISLICE CT EXAMINATION OF THE NECK, CHEST, ABDOMEN AND PELVIS
WITH CONTRAST ADMINISTRATION REVEALED:-**

- Normal appearance of the naso-, oro- and hypopharynx with preserved parapharyngeal fat planes.
- Intact laryngeal skeleton with no glottic, supra or infra glottic masses.
- Normal course and calibre of the carotid and jugular vessels.
- Normal CT appearance of the submandibular and parotid salivary glands showing homogenous enhancement. No focal solid or cystic lesions.
- Normal thyroid gland.
- No pathologically enlarged cervical lymph nodes.
- An enhancing neoplastic soft tissue mass lesion is seen in the lower outer, peri-areolar region of the left breast.
- Multiple variable sized left axillary and retro-pectineal lymph nodes are seen with loss of their hilar fat contents and the largest one measures about 24x20mm in dimensions.
- Normal right breast.
- **Benign-looking right axillary lymph nodes are seen with preserved their hilar fat contents and the largest one measures about 12mm in diameter.**
- Hyperinflated both lungs.
- A pulmonary nodule is seen in the anterior segment of both upper pulmonary lobes and the largest seen on the right side and measures about 26x21mm in dimensions.
- No other sizable abnormally-enhancing pulmonary nodules , patchy areas of consolidations or calcifications noted.
- Enhancing pretracheal lymph nodes are seen and globally measuring about 26x22mm in dimensions. Right tracheo-stripe lymph nodes are seen and measure about 29x28mm in dimensions. Carinal and subcarinal lymph nodes are seen and globally measure about 24x14mm in dimensions and aorto-pulmonary lymph nodes are also seen and measure about 39x15 mm in dimensions.
- Patent central airways.
- No pleural or pericardial effusion.
- Average size of the heart with normal CT of its big vessels.

Patient's Name:

Samah Hamid Hamad Hussein

Date:

2026-09-08

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

- Normal bones of the thoracic cage.
- Average sized liver, measuring about 14.4 cm, showing a non-homogenous parenchymal attenuation and enhancement pattern.
- Bilobar hypovascular focal lesions are seen, more in the left lobe where the largest one seen and measures about 26x22mm in dimensions.
- No dilated biliary radicles.
- Patent PV.
- Average sized spleen, measuring about 9 cm. No focal lesions seen inside.
- Relatively thickened left adrenal gland.
- Normal CT appearance of the pancreas, functioning both kidneys, right suprarenal gland, aorta and IVC.
- No sizable abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- No intra-vesical stones, solid masses, wall thickening or diverticulosis seen.
- The rest of the pelvic structures are unremarkable.

IMPRESSIONS:

- An enhancing neoplastic soft tissue mass lesion in the lower outer ,peri-areolar region of the left breast with multiple metastatic left axillary and retro-pectineal lymph nodes.
- A pulmonary nodule in the anterior segment of both upper pulmonary lobes ,with enhancing pretracheal, right tracheo-stripe, carinal , subcarinal and aorto-pulmonary lymph nodes ,bilobar hypovascular hepatic focal lesions and relatively thickened left adrenal gland, likely to be metastatic.

Prof/Hanan El-Ahwal.

Dr.Hanan Elahwel

Patient Name	سماح حامد حماد	Case No.	357706
Sex/Age	Female 38 Y	Patient No.	25818
Registered Date	12/8/2026 01:40:08 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	07/9/2026 02:34:13 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	08/9/2026 10:37:14 AM	Pathology No.	SR-935/26

Breast Slide Revision

Clinical Data: Left breast LOQ mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Referred block (Tru-cut biopsy).

Gross Examination:

- Only one referred block labelled by (625-26).

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade: 3 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 3, mitosis 2).
- * Ductal carcinoma in situ: Minimal, low grade (Cribriform pattern).
- * Angioinvasion: Absent.
- * Perineural invasion: Absent.
- * Microcalcification: Absent.

Results:

IPT: (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 40% of tumor cells (score 7/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Strong complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 3+).
- Ki67%: 50%.

Diagnosis:

Left breast mass, Referred block (Tru-cut biopsy):

- Invasive duct carcinoma, Grade 3.

IPT:

- ER: positive (7/8).
- PR: positive (8/8).



خريطة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
 Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt